



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نجوي عبدالعزيز احمد نوح
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 26911261700507 رقم التليفون : 01017615232
العنوان : =
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-11-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجوى عبدالعزيز احمد نوح National ID: 26911261700507	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

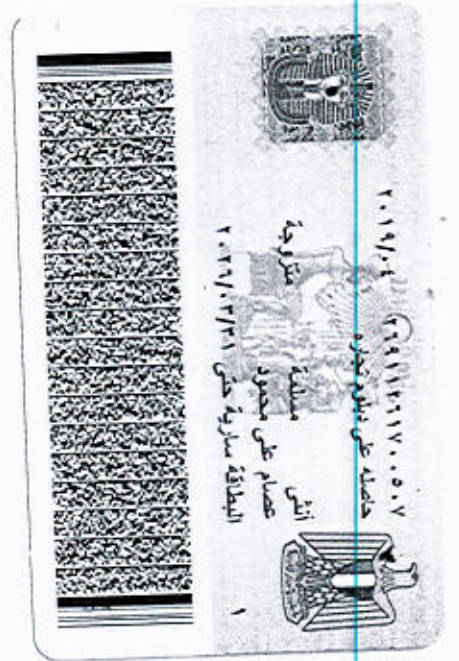
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



B/4



Name: نجوي عبدالعزيز احمد نوح		
MR. : 4808		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 57-year-old individual with a history of post-mastectomy breast cancer, diagnosed as left-side infiltrating ductal carcinoma, grade II, ER 8/8, PR 5/8, HER2 negative, clinical stage cT2N2. Neoadjuvant aromatase inhibitor therapy was initiated due to elevated liver function tests, followed by a left-triple-quadrantectomy with wide local excision and axillary lymph node dissection, resulting in a ypT2ypN3 pathological stage in 2022. Adjuvant chemotherapy with paclitaxel (Taxol) and cyclophosphamide (Endoxan) was administered for 18 weeks, after which the patient received post-operative radiotherapy. Since February 2023, the patient has been on adjuvant aromatase inhibitor therapy with Arimidex, prescribed for a 3-month course, with the next follow-up scheduled after completion of this period.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	عزه احمد عبيد الغنى
		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name : الأستاذة / نجوى عبدالعزيز احمد نوح	Request No. : 13002781
Patient No. : 26911261700501	Request Date : 12/05/2022
Path No. : 1224/22	Verification Date : 18/05/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - اقتصادي
Age : 52 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer, on Hormonal therapy.

Nature of the specimen:

Left WLE with extra lower margin, nipple surgical margin, axillary dissection.

Gross Examination:

Four specimens were received designated as:

- 1-Left WLE measuring 10x7x3 cm, No skin covering. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white mass measuring 2.5x2x2 cm, located 2 cm, 3cm, 1.5cm, 0.1cm, 0.5cm, 1cm from lateral, medial, superior, inferior, superficial and deep margins . respectively. Rest of breast showed fibrotic rubbery grayish white cut section.
- 2- Extra lower margin: Fibrofatty tissue piece; 6x4 cm. Free from gross induration.
- 3- Nipple resection margin: Three fibrofatty tissue pieces measured collectively 3x3 cm. Totally submitted.
- 4- Axilla; 10x7 cm. entangling 15 nodules, measured up to 4.5 cm in diameter.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma, GIII
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+3+2)
- Angioinvasion: yes
- Ductal carcinoma in situ: No
- Tumor extent
 - o Number: 1
 - o Size: 2.5 x 2 x 2 cm
 - o Skin involvement: No
- Lymph nodes : 15/15 with extracapsular extension
- Resection Margins: Free all margins, including nipple and extra-lower surgical margin).

Verified by :

Patient Name : الأستاذة / نجوى عبدالعزيز احمد نوح
Patient No. : 26911261700501
Path No. : 1224/22
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002781
Request Date : 12/05/2022
Verification Date : 18/05/2022
Financial Category : اوراق دار السلام - اقتصادي
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

- Histologic response to therapy: Partial Pathological response
- Additional pathologic findings: NA

Diagnosis:

Left breast cancer, Left WLE with extra lower margin, nipple surgical margin, axillary dissection ;
Invasive duct carcinoma, Grade III.
Partial Pathological response.
Free all margins, including nipple and extra-lower surgical margin .
Positive lymphatic tumor emboli.
Positive lymph nodes (15/15) with extra-capsular extension.
Stage: ypT2 ypN3.

Prof. Aml Hareedy
Dr. Walaa Ghonaim

Printing

Verified by :

Printing By : marwa m. el

Printing Date : 18/05/2022 12:06:50

Page 2 of 3

مركز الباثولوجي - مستشفى دار السلام - القاهرة - مصر
House No. (45) - First Floor, Building No. 987, Nile Corniche - Near El-Qadima, Cairo, Egypt



MDT FORM

2022/1/12

Name	فوزية محمد	MRN	6077 / 5077
Age	52y	ID	679110711000
Menopausal status	(premenopausal) - (irregular)	Phone	1109805011
OCP	(no)	marital status	married
Co morbidity	Family history		
↑ liver enzymes + bilirubin (Idiopathic cause) D2 intrahepatic cholestasis, viral hepatitis (excluded) (10/2022)			

Clinical Data

Bx:	IOC, G5	R	L
ER:	8/8	PR:	5/8
HER2:	-ve	Ki67:	50%
Sonomammography:		T2N2M0 multicentric	
Mets Workup:		pBT/CT 1/9/2021 (no mets)	

Recommendations:

D2 Idiopathic intrahepatic cholestasis
T/D bilirubin 3/2.8, the patient started Neoadj AI
for 8 months followed LT CBS + AC 11/5/2022. (Senara)
- IOC, G5
- partial pathological response
- free surgical margins, free lymphatic tumor emboli
- free (N3) 15/15 (T2N3)

MDT OUTCOME & PLAN

1) Full G5 + liver enzymes.
2) T (60mg/m²) & taxol weekly 100mg/m² + liver enzymes & clinical exam.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
محمد		محمد	

